Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Nova Alvorada do Sul
Vara Única

Autos: n. 0801147-84.2022.8.12.0054
Ação: Procedimento Comum Cível - Não padronizado
Autor: Dila Couto Insfran
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se os autos de ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência ajuizada por Dila Couto Insfran em desfavor de Município de Nova Alvorada do Sul - MS e Estado de Mato Grosso do Sul, em que visa compeli-los ao fornecimento do medicamento Jardiance 25mg (Empagliforzina).

Alegou padecer de hipertensão essencial (CID-10 I10), doença aterosclerótica do coração (CID-10 I25.1), diabetes mellitus não insulino-dependente (CID-10 E11.6) e obesidade (CID-10 E66), razão pela qual necessita do fármaco mencionado para tratamento de saúde. Sustentou que é obrigação dos requeridos o fornecimento do medicamento que necessita, pois não tem condições financeiras para sua aquisição. Requereu, assim, em tutela de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam o tratamento. Ao final, requereu a procedência do pedido e concessão do benefício da gratuidade da justiça. Juntou documentos (p. 11-40).

O Núcleo de Apoio Técnico - NAT apresentou parecer desfavorável a concessão do medicamento (p. 44-55).

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência (p. 56-60).

O requerente informou a interposição de Agravo de Instrumento (p. 70).

Devidamente citado, o Município de Nova Alvorada do Sul/MS apresentou contestação (p. 74-83), arguindo preliminarmente ***(i)*** a incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no presente feito (Tema nº 793 de Repercussão Geral) e ***(ii)*** o redirecionamento da responsabilidade para o Estado. No mérito, aduziu que o pedido da parte autora não preenche os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, ante a ausência de provas da incapacidade financeira, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às p. 92-102,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no presente feito (Tema nº 793 de Repercussão Geral). No mérito, aduziu que não estão presentes no caso em voga os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ. Subsidiariamente, requereu a não fixação de multa diária em caso de descumprimento, afirmando a impossibilidade de fixação de astreintes.

O requerente apresentou impugnação a contestação (p. 106-114).

As partes requereram o julgamento antecipado de mérito (p. 120, p. 122 e p. 124).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. **Decido.**

II - Fundamentos

2.1. Do julgamento antecipado de mérito

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, prescindindo, portanto, de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.2. Das Preliminares.

I - A preliminar apresentada pelo Município de Nova Alvorada do Sul/MS, referente à ausência de responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico postulado, onde um atribui a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso do Sul, confunde-se com o mérito da causa, portanto, com ele será analisado. A discussão acerca da competência para a disponibilização do tratamento médico vindicado é questão de mérito, não guardando relação com os pressupostos processuais ou com as condições da ação.

Assim, a legitimidade passiva está presente, já que o requerente apresenta em sua causa de pedir a alegação de que os requeridos possuem a incumbência legal de lhe disponibilizar tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde.

II - Em relação a preliminar alegada pelos requeridos sobre a incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no polo da ação (Tema nº 793 de Repercussão Geral), destaco que a tese de repercussão geral fixada a respeito do tema 793, ficou redigida nos seguintes termos: ***Os entes da federação, em***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, *e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Em 25/05/2019, ela foi aprimorada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que o Min. Edson Fachin, que proferiu o voto condutor do acórdão, esclareceu o entendimento atual da Suprema Corte. Veja-se a ementa:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.* ***1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.* ***3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.*** *Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.*
> (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Depreende-se, portanto, que a União somente deverá necessariamente integrar o polo passivo das ações que exijam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, sendo que, nos demais casos, prevalece o posicionamento quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, o que evidentemente não se aplica ao caso em tela.

Dito isso, rejeito tal preliminar.

2.3. Do mérito

No mérito, a pretensão da requerente é improcedente.

Toda pessoa tem direito ao adequado tratamento de saúde, decorrente do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido à categoria de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1.º, inc. III, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, o art. 5.º, caput, da Constituição Federal discorre que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Sendo decorrência do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a saúde é um direito fundamental do cidadão, e, como tal, tem a característica de vincular o Poder Público à sua estrita observância.

Além de configurar-se como direito fundamental e, portanto, de observância obrigatória pelo Estado, a própria Constituição Federal disciplina que a saúde é direito de todos e, conforme dito anteriormente, dever do Estado prestá-la, como se depreende do art. 196, a seguir transcrito: "*CF. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

A palavra "Estado" empregada no texto constitucional, a toda evidência (e até por questão de hermenêutica constitucional), deve ser interpretada em seu sentido *lato*, de modo a entender que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar assistência integral à saúde dos cidadãos (*trata-se de um direito fundamental prestacional).*

Em outras palavras, pela norma constitucional, há um dever solidário de assistência à saúde, o que significa dizer que **todos os entes políticos, seja qual for a esfera – Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, têm <u>responsabilidade solidária</u> no atendimento à saúde da população**.

A legislação infraconstitucional também impõe esse dever ao Estado (em sentido *lato*), ao dispor, no art. 2.º da Lei n. 8.080/90, posteriormente alterada pela Lei n. 12.401/2011, que regulamenta as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, que *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

Por todos os ângulos que se observa a questão em análise, afigura-se visível que a pessoa que necessita de tratamento médico de elevado custo, e por não ter condição econômica para suportar as despesas deste, tem o direito de receber do Estado – que por sua vez tem o dever de fornecer –, o meios necessários e imprescindíveis ao tratamento de sua doença.

É bem verdade que a Lei n. 8.080/90, em seu art. 7.º, IX, trouxe a descentralização do Sistema Único de Saúde, de maneira que cada esfera de governo ganhou autonomia e direção única para a gestão dos recursos destinados à saúde do cidadão. Também é certo que, em princípio, de acordo com a descentralização imposta pela Lei n.º 8.080/90, restou aos municípios, em caráter *preferencial* (art. 18, V, Lei 8.080/90), o dever de fornecer os medicamentos e tratamentos necessários à saúde do cidadão, já que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para exercer o dever que lhe é imposto pela Constituição Federal.

Todavia, o fato de competir aos Municípios, em caráter principal, o dever desse fornecimento, não exclui o dever dos Estados e da União, de forma suplementar, assegurar a prestação desse serviço. Aliás, essa conclusão é facilmente alcançada pela leitura do art. 17, VIII, da Lei n. 8.080/90.

Nesse raciocínio, portanto, vê-se que **a responsabilidade não é subsidiária, mas principal**, o que significa que o Estado não está isento do dever de fornecer os medicamentos e os tratamentos não elencados como excepcionais, caso o Município, que tem o dever principal nesse fornecimento, não o fizer.

A Lei 8.080/90 traduz uma divisão administrativa de atribuições, ***muito embora a responsabilidade perante o cidadão necessitado seja solidária***, quando descumprido o dever político-constitucional de fornecimento da assistência à saúde estampado na Constituição (art. 196).

Outra não poderia ser a conclusão, pois, como já dito, a Constituição Federal, em seu art. 196, ao fazer referência ao "Estado", alude a todos os entes políticos, independentemente de sua esfera de governo, de modo que eventual lei ou qualquer outro ato normativo que viesse contrariar essa regra estaria maculada pelo vício da inconstitucionalidade.

Portanto, à luz dos sistemas constitucional e legal, o cidadão pode pleitear a concessão de tratamento médico perante qualquer esfera governamental, pois o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

dever abarca todos os entes, que atuam na promoção da saúde num sistema de consórcio, mais precisamente, o Sistema Único de Saúde.

Nessa linha de entendimento colhe-se o seguinte julgado, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SERETIDE E BROMETO DE TIOTRÓPIO) - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS - TUTELA ANTECIPADA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO DE TETO LIMITE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO* ***1. A Constituição impõe a obrigação concorrente a todos os entes da Federação ao cumprimento do disposto em seu art. 196, independente de hierarquia, razão pela qual tanto o Município quanto o Estado pode ser compelido a fornecer o tratamento necessário à saúde do carente. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de conceder ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, daí a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso do Sul.*** *[...].*
> (**TJMS** - AI: 40066486420138120000 MS 4006648-64.2013.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 12/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014). (Grifei).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)–* ***EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PACIENTE PORTADOR DE ASTROCITOMA ANAPLÁSICA DO ENCÉFALO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.***
> (STF - EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 800051 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma). (Grifei).

Com efeito, nada obstante a saúde seja reconhecida como direito de todos e dever do Estado, é certo que tal direito fundamental, consistente na assistência à saúde,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

individual ou coletiva, e em qualquer grau de complexidade, não é absoluto. Isso ocorre porque os recursos públicos são escassos e as demandas crescem em progressão geométrica, de modo que tal assistência pelo Estado deve ser propiciada nos limites das possibilidades do Poder Público, em razão da comprovada deficiência financeira que assola a maioria dos entes estatais.

Em complemento, destaco o entendimento exarado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento conjunto dos recursos n.º 566.471-RS e 657.718-MG, os quais tiveram repercussão geral reconhecida, cujo trecho na parte que interessa a seguir traslada-se:

> *Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiros devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamento não incluído na política pública.*

Nesse passo, não se nega a possibilidade de se reivindicar do Estado o medicamento pretendido. Entretanto, não se pode desconsiderar que o oferecimento de tais fármacos, de modo irrestrito e desprovido de qualquer critério, sobrecarregaria em demasia o sistema de saúde brasileiro, o qual já se encontra em manifesto declínio.

Dessarte, deve o Poder Judiciário atuar com cautela e estabelecer parâmetros práticos para a sua concessão, cuja aferição deve se dar em cada caso concreto, com o propósito de enjeitar as hipóteses em que prescindível a atuação do Estado.

Através da análise de dos julgados proferidos pelos tribunais pátrios, que envolvem a concessão de medicamentos, tratamentos e equipamentos àqueles que buscam tal prestação, é possível estabelecer certos critérios para um melhor exame do provimento jurisdicional pleiteado.

(i) Por primeiro, elenca-se que a destinação dos recursos públicos devem ser dirigidos àquelas pessoas que não dispõem de condições para a aquisição, por conta própria, de medicamento/tratamento, sob pena de subverter-se o propósito do direito pleiteado.

(ii) Já o segundo corresponde à essencialidade de laudo médico que corrobore a imprescindibilidade do medicamento ou tratamento prescrito ao paciente, de modo que a sua não utilização ou substituição por outro semelhante traduza em uma piora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

no quadro de saúde do enfermo.

(iii) Por último, mas não menos importante, necessário se mostra a efetiva comprovação do benefício à saúde do paciente, com a consequente melhora de seu estado clínico, com a finalidade de se afastar tratamentos experimentais, os quais se encontram em fase de teste, cuja eficácia e segurança não se encontram presentes.

Fixadas tais premissas, há que averiguar se elas se encontram presentes no quadro litigioso.

À vista do primeiro requisito, entende-se que ele se encontra preenchido, já que o assistido não dispõe de condições financeiras para arcar com o custo do medicamentoso, tanto que fazia seus atendimentos pela rede pública de saúde, além de estar assistida processualmente pela Defensoria Pública do Estado.

Mas, igual sorte não lhe assiste quanto aos demais critérios, eis que examinando os autos, verifica-se que os laudos acostados aos autos não atestam que o medicamento seria de urgência ou risco no caso do requerente.

Pois bem. O laudo médico de p. 19-21 afirma genericamente que foi utilizado apenas um medicamento (Glifage) e que este teria sido ineficaz, ao passo que o parecer do NAT indica diversos tratamentos similares para a enfermidade, que são fornecidos pelo SUS (item "IX", p. 53-54), vejamos:

> O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Diabete Melito tipo 2, Portaria SCTIE/MS nº 54 de 11/11/2020, oferece os medicamentos Cloridrato de Metformina, Glibenclamida, Gliclazida, Insulina NPH, Insulina Regular, Dapagliflozina.
>
> A RENAME 2022 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos hipoglicemiantes (Glibenclamida, Gliclazida, Metformina, Insulina NPH, Insulina Regular), estatina (Sinvastatina), medicamentos inibidores ECA/AT1 (Captopril, Enalapril, Losartana), bloqueadores de cálcio (Anlodipino, Nifedipino, Verapamil), betabloqueadores (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, Propranolol), diuréticos (Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida), vasodilatadores (Dinitrato ou Mononitrato de Isossorbida, Hidralazina), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico).

Ora, se o SUS disponibiliza outros meios para o tratamento do mesmo diagnóstico e inexiste nos autos prova de que aqueles substitutivos não seriam eficazes ao tratamento da moléstia suportada pelo requerente, não parece legítimo obrigar o Poder Público a ofertar outros medicamentos se não aqueles disponibilizados na rede pública de saúde.

No caso em apreço, destaco que embora os documentos médicos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

juntados aos autos (p. 13-15 e 19-21) tenham sido elaborado por profissionais habilitados para este fim, não oferecem a segurança necessária para afirmar que os medicamentos fornecidos pelo SUS, não produzem os mesmos efeitos daqueles indicados pelos profissionais que acompanham a autora.

Nesse sentido, correlaciono os seguintes julgados do TJMS:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REFORMADA.* ***FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAQUELES REGULARMENTE DISPONIBILIZADOS PELO SUS.*** *TESE DO STJ – TEMA 106. RECURSO PROVIDO.* ***Não é razoável exigir do Poder Público medicamento específico, diverso daquele regularmente disponibilizado pelo SUS, especialmente não havendo comprovação da ineficácia deste último ou mesmo da imprescindibilidade da prescrição médica.***
> (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 2000756-96.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 17/01/2023, p: 18/01/2023) (grifei)
>
> *REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) -* ***EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS GRATUITAMENTE FORNECIDOS PELO PODER PÚBLICO NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE*** *– REQUERENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. [...] 3 - Em que pese a saúde ser direito de todos, consoante respaldo constitucional (arts. 23, II, e 196), a procedência de toda e qualquer ação fundada no tema, conforme vinha ocorrendo sob esse fundamento constitucional genérico e abstrato, terminava por produzir um verdadeiro caos no orçamento público, pois exigia a adoção de providências sem qualquer lastro de previsão financeira, impactando demasiadamente nos cofres públicos e na própria condução das demais políticas públicas, ante a manifesta escassez de recursos. 4 - Ademais, sendo a saúde espécie do gênero seguridade social, e o fornecimento de remédios uma das várias prestações deste, devem ser observados os princípios básicos que subsidiam o sistema da Seguridade, in casu, a seletividade (art. 194, par. ún., inc. III da Constituição Federal), princípio voltado ao legislador e ao administrador público, que devem eleger quais contingências estão aptas ao resguardo pelo Poder Público, pautado no ideal de prestações que comportem a mais ampla proteção social possível, tendo sempre por norte a solidariedade como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º da Carta Magna). Nesta toada, interessante pontuar que quando conveniente, tanto legislador quanto o gestor público (claro que a este dentro da discricionariedade administrativa proporcionada pela norma), selecionam as prestações (medicamentos e procedimentos) devidos à população, como por exemplo, a distribuição de medicamentos para o combate do vírus HIV, direito subjetivo amparado pela Lei nº 9.313/96, ou os medicamentos distribuídos pelo SUS na rede pública de saúde. 5 -* ***Se há tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não há razão para o Judiciário interferir nas decisões legislativas e administrativas sobre a pretensa justificativa da existência do direito fundamental à vida e à saúde, afinal, as leis devem ser compreendidas dentro de um sistema***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

> ***interpretativo que promova a harmonia entre as normas que o compõem, sem interpretações isoladas e, no mais das vezes, desastrosas à implementação de políticas públicas. 6 - A flexibilização desse raciocínio pelo Judiciário só seria possível ante as peculiaridades do caso concreto, anotadas à situação urgente em que há o risco iminente à vida do paciente e a utilização anterior dos medicamentos ou demais procedimentos prestados pelo SUS, além de não tratar-se de tratamento experimental – pelo qual as incertezas de seus efeitos subsidiam a obstaculização de seu fornecimento pelo juiz, com amparo no princípio da precaução. 7 – Não tratando-se, in casu, de situação que excepciona a orientação firmada, a revogação da liminar concedida é medida que se impõe.*** *[...] 9 - Reexame necessário e recurso de apelação dos Estado de Mato Grosso do Sul providos. Recurso da Defensoria Pública Estadual prejudicado.*
> (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0801303-16.2019.8.12.0042, Rio Verde de Mato Grosso, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2021, p: 21/09/2021)

Ou seja, o direito à saúde, embora seja obrigação do Estado, não assegura de forma irrestrita o fornecimento do medicamento pretendido pelo paciente, sem caráter de urgência, preterindo outros que, melhores posicionados na lista de espera organizada pelo órgão de saúde, aguardam o mesmo procedimento, sob pena de ruptura do princípio da isonomia.

Em auxílio ao tema em discussão, oportuna a invocação do Enunciado 16 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, realizado em 15/05/2014, em São Paulo/SP:

> *[...] "nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS".*

Assim, demonstrado que a requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, inc. I, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos autos pelos requeridos e pelo parecer técnico do NAT, outra solução não resta senão a improcedência da demanda.

III – Dispositivo:

Isso posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da lide e **julgo improcedente** o pedido formulado na inicial, em face do Município de Nova Alvorada do Sul/MS e Estado de Mato Grosso do Sul, também qualificado.

Sem custas e honorários.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

Nova Alvorada do Sul, *datado e assinado digitalmente.*

Juliano Luiz Pereira
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 16/06/2023 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801147-84.2022.8.12.0054 e código 8kvY8fxF.